随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

五、糖尿病的检查



（一）尿糖

诊断糖尿病的线索（提示血糖超过肾糖阈）：阴性不能排除糖尿病、阳性不等于糖尿病

《生理学》：血糖≥180 尿糖(+)

肾糖阈是尿中刚开始出现葡萄糖的最低血糖浓度

反应葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系

①肾糖阈增高（＞180mg/dl，假阴性）：如 GFR 降低（老年人、肾小球肾炎、糖尿病肾病）肾脏有问题
结果是阴性，但是不该是阴性　滤过少，进到近端小管糖↓→就需要更高的血糖浓度尿中才会出现葡萄糖

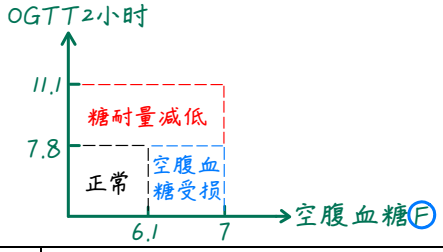
②肾糖阈降低（＜180mg/dl，假阳性）：如 GFR 升高（妊娠）、肾性糖尿（近端小管对葡萄糖重吸收障碍）
很容易出现尿糖，但此时不是糖尿病　血容量↑ 与胰岛素无关 糖耐量正常　糖耐量↓：胖机甲a尿尿

（二）血糖（反映瞬间血糖状态）

（1）测定**静脉血浆**葡萄糖（血浆血糖比全血血糖高 15%）
含细胞，会消耗葡萄糖
没有典型症状的患者会要求过几天再测血糖

（2）**确诊标准（任意一项达标）：三多一少等典型症状+**

血糖
①**空腹血糖 FPG**（隔夜禁食 8 小时后第二天**早晨**测得）≥**7**mmol/L　fasting
②口服葡萄糖耐量试验 **OGTT 2 小时**血糖（2hPG）≥**11.1**
③**随机**血糖（任意时间）≥**11.1**　711
④**HbA1c≥6.5%**　765



（3）糖代谢状态：

	OGTT 2 小时血糖	空腹血糖
正常血糖（六一吃吧）	＜7.8	＜6.1
空腹血糖受损	＜7.8	6.1-＜7
糖耐量减低	**7.8-＜11.1** 对G耐受程度↓空腹血糖有可能会↑	**＜7**
糖尿病	>11.1	>7

（4）血糖控制目标：空腹血糖 4.4-7、非空腹血糖＜10mmol/L

（三）糖化血红蛋白 HbA1c　红细胞寿命4个月

（1）反映近 **2-3 个月**内**平均**血糖水平（评价**长**期血糖控制情况）4个月-(1-2个月)=(2-3个月)

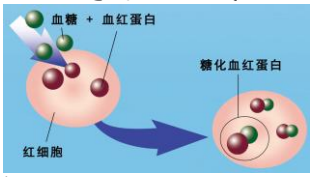
对比：糖化白蛋白/果糖胺反映近 2-3 周内平均血糖水平（评价短期血糖控制情况）白蛋白半衰期短于RBC



（2）HbA1c 不能反映瞬时血糖水平、不能反映血糖波动情况、不能确定是否发生过低血糖
①T2DM多数不需胰岛素(但新诊断基线HbA1c≥9%或空腹血糖≥11.1要短期给胰岛素强化)
②确诊标准:HbA1c≥6.5%

（3）HbA1c 控制目标：**＜7%**（HbA1c 数据小结：九儿遛我妻）　HbA1c 9% 6.5% 7%

RBC通过GLUT摄取G



血红蛋白产生1-2个月后才会与G发生糖化作用
↓
形成糖化血红蛋白，持续存在直到红细胞凋亡